Hồ sơ thực hiện tiêu chí C6.3

Người bệnh được theo dõi chăm sóc phù hợp với tình trạng bệnh và phân cấp chăm sóc

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN — PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Dự thảo trình duyệt năm 2026. Hồ sơ gồm yêu cầu đối chiếu, quy định tổ chức chăm sóc, kế hoạch triển khai và biểu mẫu để bệnh viện ghi nhận hoạt động thực tế. Chưa có dữ liệu để kết luận mức đạt của bệnh viện.

Số văn bản và phiên bản chính thức .....

Ngày phê duyệt và ngày áp dụng .....

Người soạn thảo .....

Người rà soát chuyên môn .....

Người phê duyệt .....

Phạm vi và nguyên tắc sử dụng

Áp dụng cho các khoa điều trị nội trú và đơn vị phối hợp. Các nội dung chăm sóc phải cá thể hóa theo nhận định, chẩn đoán điều dưỡng, kế hoạch, thực hiện và đánh giá. Mã biểu mẫu trong hồ sơ là mã đề xuất, cần thống nhất với hệ thống quản lý tài liệu và hồ sơ bệnh án.

Hồ sơ C6.3 là công cụ quản lý và cải tiến chăm sóc. Các quy trình kỹ thuật kèm theo phải được xây dựng theo đề cương QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 và đối chiếu hướng dẫn chuyên môn tương ứng. Hồ sơ này không thay thế quy trình kỹ thuật, y lệnh hoặc biểu mẫu bệnh án bắt buộc.

Không ký thay, không ghi lùi ngày, không mặc định không có sự cố. Chỉ sử dụng số liệu và minh chứng đã được xác minh; các trường chưa có thông tin giữ trống để bổ sung.

1 Căn cứ và phương pháp tự đánh giá

Căn cứ tiêu chí: QĐ6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016, Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam phiên bản 2.0, C6.3, trang in 95–96 [1]. Hoạt động chăm sóc đối chiếu Thông tư 31/2021/TT-BYT, đặc biệt Điều 4–7 [2]. Quyền người bệnh đối chiếu Luật Khám bệnh, chữa bệnh 15/2023/QH15 [3]. Không dùng TT07/2011/TT-BYT hoặc Luật năm 2009 trong phần căn cứ của tiêu chí cũ như văn bản hiện hành.

Trước kỳ đánh giá, bộ phận QLCL xác nhận hướng dẫn đánh giá áp dụng và đối chiếu thêm tiêu chuẩn chất lượng cơ bản theo TT35/2024/TT-BYT. Bộ hồ sơ này không tự xác nhận bệnh viện đáp ứng toàn bộ tiêu chuẩn hoặc điều kiện hoạt động.

Cách xác định mức

Kiểm tra hai tình trạng bất lợi mức 1 trước: sự cố chăm sóc gây tử vong hoặc tổn thương không hồi phục nhưng không tự nguyện báo cáo kịp thời theo mô tả của tiêu chí; hoặc chưa có quy định theo dõi, chăm sóc, vệ sinh, phục hồi chức năng. Không chuyển tình trạng bất lợi thành mục “đạt”.

Sau khi loại trừ tình trạng mức 1, đánh giá lần lượt các yêu cầu tích lũy mức 2 đến mức 5 bằng hồ sơ, quan sát, phỏng vấn và dữ liệu. Không tính mức bằng trung bình số ô đạt. Chưa xác minh thì ghi rõ, không suy ra đạt từ việc có biểu mẫu.

Trường hợp không có nhóm người bệnh đặc thù

Ghi chú của C6.3 cho phép không đánh giá và coi như đạt các khoản có dấu * nếu bệnh viện không có người bệnh chăm sóc cấp I/II, có phẫu thuật hoặc giai đoạn cuối tương ứng. Phải xác minh phạm vi hoạt động và dữ liệu trong kỳ; lưu căn cứ, không chỉ ghi “không áp dụng” vì tại thời điểm kiểm tra chưa gặp người bệnh.

Mẫu số bằng 0 của một chỉ số không tự đồng nghĩa tỷ lệ 0% hoặc 100%. Quy tắc không áp dụng của tiêu chí và cách tính chỉ số là hai việc khác nhau; cần trình bày riêng trong báo cáo.

2 Ma trận yêu cầu mức 1 đến mức 3

Diễn giải rút gọn từ [1]. Dấu * áp dụng theo ghi chú ở mục 1 của hồ sơ; dùng cùng bản gốc khi tự đánh giá.

Mục mức	Yêu cầu đối chiếu	Minh chứng cần có
1 M1	Có sự cố chăm sóc sai hướng dẫn gây tử vong/tổn thương không hồi phục nhưng không tự nguyện báo cáo kịp thời	Hồ sơ sự cố, thời điểm và bằng chứng báo cáo theo mô tả văn bản gốc.
2 M1	Chưa có quy định theo dõi, chăm sóc, vệ sinh và phục hồi chức năng	Kiểm tra văn bản hiện có và hiệu lực.
3 M2	Có quy định cụ thể về theo dõi, chăm sóc, vệ sinh cá nhân và phục hồi chức năng	Văn bản được phê duyệt, nội dung đầy đủ.
4 M2	Phổ biến, tập huấn cho điều dưỡng, hộ sinh và nhân viên liên quan	Kế hoạch, tài liệu, danh sách và kết quả.
5 M2	Hướng dẫn người bệnh và người nhà theo dõi, chăm sóc	Ghi phiếu chăm sóc, quan sát và phỏng vấn.
6 M3	Đủ phương tiện cơ bản cho chăm sóc thể chất và vệ sinh	Danh mục, số lượng, tình trạng và kiểm tra thực tế.
7 M3	Người nhà được điều dưỡng tập huấn và làm mẫu chăm sóc	Nội dung hướng dẫn, thực hành lại, ghi nhận.
8 M3	Người nhà không thực hiện công việc chuyên môn như thay băng, thay dịch truyền	Phân công, quan sát, phỏng vấn và xử lý vi phạm.
9 M3	Điều dưỡng, hộ sinh phối hợp bác sĩ đánh giá phân cấp chăm sóc	Nhận định, phân cấp, thời điểm và cập nhật.

3 Ma trận chăm sóc cấp II và nhóm đặc thù

Diễn giải rút gọn từ [1]. Dấu * áp dụng theo ghi chú ở mục 1 của hồ sơ; dùng cùng bản gốc khi tự đánh giá.

Mục mức	Yêu cầu đối chiếu	Minh chứng cần có
10 M3	Điều dưỡng trưởng đi buồng kiểm tra hằng ngày và khi cần	Sổ đi buồng, tồn tại và theo dõi xử lý.
11 M3	Kiểm soát chế độ ăn bệnh lý, ăn qua ống thông; ghi phiếu chăm sóc	Y lệnh, thực hiện, dung nạp và ghi chép.
12 M3	Nhân viên y tế đáp ứng nhu cầu ăn uống, vận động và phục hồi chức năng	Kế hoạch, phân công, thực hiện và đánh giá.
13 M3	Ghi can thiệp chăm sóc vào hồ sơ bệnh án	Phiếu chăm sóc và xác nhận người thực hiện.
14 M3	Hướng dẫn, hỗ trợ và tập phục hồi chức năng khi có nhu cầu	Đánh giá nhu cầu, phối hợp, ghi nhận.
15 M3	Toàn bộ người bệnh chăm sóc cấp II được đánh giá nhu cầu và lập kế hoạch *	Danh sách cấp II, hồ sơ đối chiếu từng người.
16 M3	Toàn bộ người bệnh chăm sóc cấp II được chăm sóc toàn diện *	Phân công, chăm sóc thể chất và vệ sinh cá nhân.
17 M3	Người bệnh phẫu thuật được hướng dẫn, hỗ trợ, chuẩn bị trước mổ *	Hồ sơ chuẩn bị và bảng kiểm phù hợp.
18 M3	Người bệnh giai đoạn cuối được hỗ trợ giảm đau, thể chất và tinh thần *	Nhận định triệu chứng, kế hoạch, thực hiện và đáp ứng.

4 Ma trận chăm sóc cấp I và cải tiến

Diễn giải rút gọn từ [1]. Dấu * áp dụng theo ghi chú ở mục 1 của hồ sơ; dùng cùng bản gốc khi tự đánh giá.

Mục mức	Yêu cầu đối chiếu	Minh chứng cần có
19 M4	Toàn bộ người bệnh chăm sóc cấp I được đánh giá nhu cầu và lập kế hoạch *	Danh sách cấp I, hồ sơ đối chiếu từng người.
20 M4	Toàn bộ người bệnh chăm sóc cấp I được chăm sóc toàn diện *	Phân công theo dõi liên tục và ghi nhận chăm sóc.
21 M4	Có phương tiện phòng chống loét do tỳ đè	Kiểm kê, khả năng sử dụng và tiếp cận thực tế.
22 M4	Có nhân viên hoặc dịch vụ hỗ trợ chăm sóc thể chất, vệ sinh	Phạm vi công việc, nhân sự, giám sát an toàn.
23 M5	Xây dựng và đo lường chỉ số theo dõi, chăm sóc	Định nghĩa, dữ liệu, phép tính và chuỗi theo dõi.
24 M5	Phòng Điều dưỡng so sánh các khoa bằng biểu đồ	Biểu đồ, dữ liệu nguồn và phân tích khác biệt.
25 M5	Các khoa theo dõi chỉ số theo thời gian bằng biểu đồ	Biểu đồ từng khoa và nhận xét xu hướng.
26 M5	Có đánh giá hoặc nghiên cứu toàn viện, chỉ rõ tồn tại và giải pháp	Đề cương, dữ liệu, báo cáo và giới hạn.
27 M5	Tỷ lệ loét do tỳ đè giảm dần hằng năm hoặc bằng 0%	Dữ liệu năm, định nghĩa ổn định, xác minh ca.
28 M5	Tỷ lệ viêm phổi do ứ đọng giảm dần hằng năm, tiến tới không có hoặc bằng 0%	Ca do bác sĩ xác định, dữ liệu năm và xu hướng.
29 M5	Thực hiện cải tiến theo kết quả đo lường, đánh giá	Kế hoạch, bằng chứng triển khai và đo lại.

5 Phân cấp chăm sóc và trách nhiệm

Phân cấp theo Điều 4 TT31/2021/TT-BYT [2], dựa trên tình trạng và mức phụ thuộc thực tế, không suy từ tên bệnh hoặc tên khoa. Điều dưỡng, hộ sinh phối hợp bác sĩ đánh giá và ghi nhận; cập nhật khi diễn biến hoặc khả năng tự chăm sóc thay đổi.

Cấp	Đặc điểm và cách tổ chức chăm sóc
I	Người bệnh nặng, nguy kịch không tự thực hiện hoạt động cá nhân hằng ngày hoặc do chuyên môn không được vận động; phụ thuộc hoàn toàn vào theo dõi, chăm sóc toàn diện và liên tục của điều dưỡng.
II	Người bệnh nặng, hạn chế vận động một phần do sức khỏe hoặc yêu cầu chuyên môn; phụ thuộc phần nhiều vào điều dưỡng khi thực hiện hoạt động cá nhân hằng ngày.
III	Người bệnh có thể vận động, đi lại không hạn chế; tự thực hiện tất cả hoặc hầu hết hoạt động cá nhân hằng ngày dưới hướng dẫn của điều dưỡng.

Đầu mối	Trách nhiệm đề xuất
Ban Giám đốc	Phê duyệt, bảo đảm nguồn lực và điều phối khi thiếu người, phương tiện.
Phòng Điều dưỡng	Tổ chức mô hình chăm sóc, đào tạo, giám sát, chỉ số và cải tiến.
Trưởng khoa và bác sĩ	Đánh giá điều trị, phối hợp phân cấp, chỉ định và xử trí bất thường.
Điều dưỡng trưởng	Phân công theo cấp chăm sóc, đi buồng hằng ngày và khi cần; khắc phục thiếu hụt.
Điều dưỡng, hộ sinh	Nhận định, chẩn đoán điều dưỡng, kế hoạch, thực hiện, đánh giá và bàn giao.
Bộ phận liên quan	Dinh dưỡng, PHCN, KSNK, dược, QLCL phối hợp đúng phạm vi nhiệm vụ.

Chốt mô hình chăm sóc và phân công từng ca theo số người bệnh, mức độ nặng và năng lực nhân viên. Không để khoảng trống trách nhiệm khi người phụ trách nghỉ hoặc chuyển ca.

6 Tổ chức quá trình chăm sóc

Nhận định

Tiếp nhận thông tin, xác minh người bệnh, nhận định hô hấp, tuần hoàn, ý thức, đau, dinh dưỡng, bài tiết, vận động, da, vệ sinh, giấc ngủ, tâm lý và nhu cầu giáo dục sức khỏe. Xác định vấn đề cấp bách và nguy cơ; ưu tiên xử trí, gọi hỗ trợ khi bất thường.

Chẩn đoán và kế hoạch

Xác định vấn đề điều dưỡng từ dữ liệu; đặt mục tiêu cụ thể, can thiệp, tần suất theo dõi, người thực hiện và thời điểm lượng giá. Phối hợp bác sĩ xác nhận phân cấp. Người cấp I và II cần kế hoạch cá thể, không chỉ sao chép kế hoạch chung của bệnh.

Thực hiện

Chăm sóc toàn diện theo mức phụ thuộc: hỗ trợ hô hấp theo chỉ định, dinh dưỡng và nuốt an toàn, bài tiết, vận động/tư thế, da, vệ sinh và tinh thần. Kiểm tra chống chỉ định và y lệnh trước can thiệp; thực hiện kỹ thuật bằng quy trình đã được duyệt.

Theo dõi và báo động

Tần suất và ngưỡng báo động theo tình trạng, y lệnh và quy định chuyên môn đã được bệnh viện duyệt. Không áp dụng một tần suất sinh hiệu cho mọi người bệnh. Khi diễn biến xấu, đánh giá ngay, gọi bác sĩ/đội cấp cứu, thực hiện xử trí trong phạm vi và ghi thời điểm, đáp ứng.

Đánh giá và bàn giao

So sánh với mục tiêu, ghi kết quả đạt/chưa đạt và nguyên nhân; điều chỉnh kế hoạch. Bàn giao cấp chăm sóc, nguy cơ, thuốc/thiết bị đang sử dụng, việc chưa xong và kế hoạch tiếp theo. Ghi người giao nhận, thời điểm và phương thức xác nhận.

Mọi can thiệp phải ghi trong hồ sơ bệnh án được phê duyệt; biểu mẫu bổ trợ cần liên kết rõ, tránh ghi trùng hoặc bỏ sót. Việc chưa làm phải ghi lý do và phương án xử lý, không xác nhận trước khi thực hiện.

7 Chăm sóc toàn diện và hỗ trợ người nhà

Điều dưỡng chịu trách nhiệm tổ chức chăm sóc theo phân cấp. Người nhà được hướng dẫn và làm mẫu những hỗ trợ phù hợp như vệ sinh, hỗ trợ ăn uống, vận động khi đã đánh giá an toàn. Không giao thay băng, chăm sóc vết thương, thay dịch truyền hoặc công việc chuyên môn khác cho người nhà.

Chế độ ăn bệnh lý và ăn qua ống thông phải kiểm soát đúng chỉ định, người bệnh, đường dùng và khả năng dung nạp; ghi lượng thực nhận, dấu hiệu bất thường và thông báo bác sĩ. Hồ sơ này không hướng dẫn thao tác đặt ống hoặc bơm ăn thay cho quy trình chuyên môn.

Phòng tổn thương do tỳ đè: nhận định nguy cơ và da, lập kế hoạch giảm áp và thay đổi tư thế cá thể hóa, quản lý ẩm, hỗ trợ dinh dưỡng và phương tiện phù hợp. Không ấn định một lịch xoay trở cho mọi bệnh nhân khi chưa đánh giá tình trạng và thiết bị hỗ trợ.

Phòng biến chứng hô hấp do bất động hoặc ứ đọng: theo dõi hô hấp, tư thế và vận động theo khả năng, vệ sinh răng miệng, phối hợp PHCN và chăm sóc đường thở đúng chỉ định. Vỗ rung, hút đờm hoặc kỹ thuật khác chỉ thực hiện sau đánh giá chỉ định/chống chỉ định bởi nhân viên có năng lực.

Trước mổ: kiểm tra danh tính, thông tin điều trị, chuẩn bị theo y lệnh, hồ sơ và bảng kiểm được duyệt; bàn giao đầy đủ. Người giai đoạn cuối cần giảm đau và triệu chứng theo chỉ định, chăm sóc thể chất, giao tiếp, hỗ trợ tâm lý, tín ngưỡng và gia đình phù hợp mong muốn.

Nếu sử dụng nhân viên hoặc dịch vụ hỗ trợ, xác định phạm vi công việc, năng lực, người giám sát và cơ chế báo bất thường. Dịch vụ hỗ trợ không thay thế trách nhiệm chuyên môn của điều dưỡng và không buộc người bệnh thuê để được chăm sóc thiết yếu.

8 Kế hoạch triển khai và đào tạo

T0 là ngày phê duyệt thực tế. Mục tiêu mức cần đạt, kinh phí và nhân lực: [BỔ SUNG sau khảo sát]. Thời hạn sau đây là đề xuất nội bộ, không phải thời hạn bắt buộc trong C6.3.

Thời hạn	Công việc	Đầu mối
T0 + 15 ngày	Rà soát 29 tiểu mục; thống kê cấp I/II, danh mục quy trình và phương tiện; xác định thiếu hụt.	Điều dưỡng, khoa, QLCL
T0 + 30 ngày	Trình quy định, phân công, biểu mẫu, định nghĩa chỉ số và chương trình tập huấn.	Phòng Điều dưỡng
T0 + 60 ngày	Tập huấn; thực hành nhận định và ghi kế hoạch; kiểm tra phương tiện, thử thu thập dữ liệu.	Các khoa và đầu mối
T0 + 90 ngày	Giám sát hồ sơ và tại giường, phản hồi kết quả, giao việc khắc phục, đo lại.	Điều dưỡng và QLCL
Hằng ngày, tháng, năm	Đi buồng hằng ngày; tổng hợp tháng; đối chiếu xu hướng năm và cập nhật khi thay đổi.	Điều dưỡng trưởng, PĐD

Nội dung đào tạo: phân cấp, quá trình chăm sóc, ghi hồ sơ, an toàn dinh dưỡng, da, vệ sinh, vận động, báo bất thường, bàn giao và hướng dẫn người nhà. Lưu chương trình, tài liệu, người tham dự thực tế, kiểm tra năng lực và học bù; không tự đặt tỷ lệ 50/70/90% của C6.2 vào C6.3.

Mô hình chăm sóc được lựa chọn .....

Nguồn lực và cách xử lý khi thiếu nhân sự .....

Lịch giám sát và người phụ trách .....

Ngày rà soát lại .....

9 Chỉ số chăm sóc và quy tắc dữ liệu

Chỉ số đề xuất	Tử số và mẫu số
Đánh giá và lập kế hoạch cấp I hoặc II	Tính riêng mỗi cấp: số người bệnh được kiểm tra có đủ nhận định nhu cầu và kế hoạch cá thể / tổng số người bệnh thuộc cấp đó được kiểm tra × 100%.
Thực hiện chăm sóc toàn diện cấp I hoặc II	Tính riêng: số người bệnh được kiểm tra có đủ chăm sóc theo nhu cầu và phân cấp / tổng số người bệnh thuộc cấp đó được kiểm tra × 100%.
Loét do tỳ đè mới phát sinh trong viện	Số đợt điều trị có ít nhất một tổn thương do tỳ đè mới phát sinh trong viện / tổng số đợt nội trú kết thúc trong kỳ × 100%. Ghi tổn thương có sẵn lúc nhập viện riêng.
Viêm phổi do ứ đọng mới phát sinh	Số đợt nội trú có viêm phổi mới phát sinh được bác sĩ xác định liên quan ứ đọng theo định nghĩa bệnh viện phê duyệt / tổng số đợt nội trú kết thúc trong kỳ × 100%. Không tự quy mọi viêm phổi thành do ứ đọng.

Hai chỉ số kết quả là định nghĩa vận hành đề xuất, cần chuyên khoa/KSNK/QLCL thống nhất trước đo. Bổ sung tiêu chuẩn nhận diện ca, thời điểm khởi phát, cách xác minh, xử lý chuyển khoa và ca không rõ nguồn gốc; tránh tính trùng một đợt tại nhiều khoa.

Lập bảng theo tháng và tổng hợp năm, vẽ biểu đồ theo khoa và theo thời gian. Khi so sánh phải giữ định nghĩa và xem xét mức độ nặng, nguy cơ, cơ cấu người bệnh, khả năng phát hiện và cỡ mẫu; không xếp hạng khoa chỉ từ tỷ lệ thô.

Không có ca báo cáo không tự chứng minh bằng 0%; cần đối chiếu hồ sơ, sổ sự cố và giám sát. Mẫu số bằng 0 ghi không tính được. Chưa có dữ liệu nhiều năm thì chưa đủ căn cứ kết luận giảm dần hằng năm. Khảo sát mẫu không chứng minh yêu cầu “toàn bộ” nếu không có dữ liệu bao phủ bổ sung.

10 Phiếu nhận định và kế hoạch chăm sóc BM01

Mã đề xuất C63 BM01. Tích hợp hoặc dẫn chiếu vào hồ sơ chăm sóc chính thức.

Mã người bệnh, đợt điều trị, khoa và giường .....

Ngày giờ, người nhận định và bác sĩ phối hợp .....

Cấp chăm sóc: ☐ I ☐ II ☐ III Lý do và thời điểm đánh giá lại: .....

Nhu cầu hoặc nguy cơ	Nhận định cụ thể	Vấn đề ưu tiên
Hô hấp và tuần hoàn		
Ý thức, đau và tâm lý		
Dinh dưỡng, nuốt và bài tiết		
Vận động, da và vệ sinh		
Giấc ngủ và giáo dục sức khỏe		

Chẩn đoán điều dưỡng	Mục tiêu và hạn đánh giá	Can thiệp, tần suất, người thực hiện

Đánh giá đáp ứng và điều chỉnh kế hoạch .....

Thông tin báo bác sĩ hoặc bàn giao .....

Người thực hiện và người tiếp nhận .....

11 Theo dõi thực hiện chăm sóc và bàn giao BM02

Mã đợt điều trị, khoa, ngày và ca .....

Cấp chăm sóc và điều dưỡng phụ trách .....

Nội dung theo kế hoạch	Giờ và kết quả thực hiện	Đáp ứng hoặc việc còn lại
Sinh hiệu và dấu hiệu cảnh báo		
Chế độ ăn, lượng nhận và dung nạp		
Vệ sinh, bài tiết và đồ vải		
Da, tư thế và phương tiện giảm áp		
Vận động và phục hồi chức năng		
Thuốc, kỹ thuật theo y lệnh		
Đau, tinh thần và hướng dẫn		

Bất thường, giờ phát hiện và người được báo .....

Xử trí theo chỉ định, thời gian và đáp ứng .....

Việc chưa thực hiện, lý do và kế hoạch .....

Giờ bàn giao và người giao nhận .....

Không ghi “bình thường” hoặc đánh dấu hoàn thành khi chưa kiểm tra. Ghi tần suất cụ thể theo kế hoạch cá thể và diễn biến; phiếu này không thay thế bảng theo dõi chuyên khoa hoặc phiếu thực hiện thuốc.

12 Kiểm tra đi buồng và phương tiện BM03

Khoa, ngày giờ và người kiểm tra .....

Số người bệnh cấp I, II, III thực tế .....

Nội dung kiểm tra	Kết quả và minh chứng	Khắc phục, người và hạn
Phân cấp và phân công từng ca		
Kế hoạch cá thể cấp I và II		
Chăm sóc thể chất, vệ sinh thực tế		
Chế độ ăn bệnh lý hoặc qua ống		
Ghi hồ sơ và bàn giao		
Người nhà được hướng dẫn đúng phạm vi		
Da, đường thở và an toàn vận động		

Phương tiện cần có tại đơn vị	Có, đủ, sử dụng được	Thiếu và phương án
Đồ dùng vệ sinh và chăm sóc		
Phương tiện hỗ trợ tư thế, vận động		
Phương tiện giảm áp phù hợp		
Phương tiện theo dõi, gọi hỗ trợ		

Việc cần xử lý ngay và người được báo .....

Ngày kiểm tra lại và xác nhận kết quả .....

13 Hướng dẫn người nhà và nhóm đặc thù BM04

Mã đợt điều trị, ngày và người hướng dẫn .....

Người được hướng dẫn và quan hệ .....

Nội dung phù hợp nhu cầu	Đã làm mẫu và thực hành lại	Kết quả và cần bổ sung
Vệ sinh và hỗ trợ sinh hoạt		
Hỗ trợ ăn uống theo đánh giá an toàn		
Hỗ trợ vận động, tư thế theo chỉ định		
Nhận biết bất thường và gọi hỗ trợ		

□ Đã giải thích người nhà không tự thay băng, thay dịch hoặc làm công việc chuyên môn. Kết quả nhắc lại: .....

Chỉ hoàn thành ô khi đã thực hiện; không mặc định mọi người nhà đều có thể hỗ trợ.

Nhóm đặc thù nếu có	Nhu cầu và kế hoạch	Thực hiện và đáp ứng
Người bệnh phẫu thuật		
Người bệnh giai đoạn cuối		

Nội dung chưa làm, lý do và người tiếp nhận .....

Người ghi và xác nhận theo quy định .....

14 Đào tạo và giám sát năng lực BM05

Chương trình, ngày học và giảng viên .....

Quy định, quy trình và phiên bản sử dụng .....

Mã nhân viên và khoa	Nội dung đã học	Kết quả và học bù

Nội dung thực hành quan sát	Đạt	Chưa đạt	Bằng chứng
Nhận định và phối hợp phân cấp			
Lập kế hoạch cá thể theo nhu cầu			
Thực hiện chăm sóc an toàn			
Ghi đáp ứng và báo bất thường			
Bàn giao, hướng dẫn người nhà			

Tiêu chuẩn hoàn thành được bệnh viện phê duyệt .....

Người đánh giá, ngày và kế hoạch kiểm tra lại .....

15 Ghi nhận ca và theo dõi chỉ số BM06

Sổ chi tiết lưu trong hệ thống được phân quyền; báo cáo tổng hợp dùng mã đợt điều trị, không công khai thông tin định danh.

Mã đợt và khoa	Nhập viện và khởi phát	Loại tổn thương hoặc chẩn đoán	Xác minh và xử lý

Tình trạng có sẵn khi nhập viện .....

Người xác minh và định nghĩa ca áp dụng .....

Kỳ và khoa	Tử số	Mẫu số	Tỷ lệ	Nguồn và ghi chú

Tên chỉ số: ..... Phiên bản định nghĩa: .....

Đối chiếu trùng và kiểm tra dữ liệu .....

Nhận xét xu hướng và yếu tố ảnh hưởng .....

Nơi lưu biểu đồ theo khoa và theo thời gian .....

16 Báo cáo đánh giá và cải tiến BM07

Kỳ, phạm vi và người phụ trách .....

Câu hỏi đánh giá và mục tiêu .....

Cách chọn đối tượng, cỡ mẫu và nguồn dữ liệu .....

Kết quả theo chỉ số	Số liệu và so sánh	Giới hạn và tồn tại

Phân tích nguyên nhân ưu tiên .....

Giải pháp lựa chọn và nguồn lực .....

Hành động	Người phụ trách	Thời hạn	Kết quả đo lại

Ngày phản hồi khoa và bằng chứng tiếp nhận .....

Điều chỉnh sau đánh giá lại .....

Người lập, rà soát và phê duyệt .....

Không kết luận cải tiến đã có hiệu quả khi chưa có dữ liệu đo lại. Lưu cả tồn tại chưa khắc phục và kế hoạch tiếp tục.

17 Danh mục minh chứng và phiếu tự đánh giá BM08

Nhóm	Nội dung cần lưu	Mã và vị trí
MC01	Quy định, phê duyệt, phân công, tài liệu và đào tạo.	
MC02	Danh sách phân cấp, phiếu chăm sóc, kế hoạch và bàn giao.	
MC03	Đi buồng, chăm sóc toàn diện, hướng dẫn người nhà.	
MC04	Danh mục và tình trạng phương tiện, nhân viên hỗ trợ.	
MC05	Chuẩn bị phẫu thuật, chăm sóc giai đoạn cuối nếu có.	
MC06	Chỉ số, dữ liệu nguồn, biểu đồ khoa/thời gian/năm.	
MC07	Báo cáo, phản hồi, cải tiến và bằng chứng đo lại.	
MC08	Hồ sơ sự cố, báo cáo và xác minh không áp dụng.	

Kỳ đánh giá và người kiểm tra .....

Tình trạng bất lợi mức 1 và căn cứ .....

Các tiểu mục chưa đủ minh chứng .....

Trường hợp có dấu sao không áp dụng và bằng chứng .....

Mức đề xuất và việc cần hoàn thành trước kết luận .....

Sử dụng bảng đối chiếu 29 mục ở phụ lục cuối; mỗi dòng phải có kết quả và vị trí minh chứng. Không dùng bảng kiểm đi buồng thay cho toàn bộ tiêu chí.

Phụ lục tự đánh giá tiểu mục 1 đến 15

Kỳ: ..... Người kiểm tra: .....

Mục	Có tình trạng bất lợi hoặc đáp ứng yêu cầu	Mã minh chứng	Việc cần bổ sung
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Mục 1–2: ghi có/không tình trạng bất lợi. Mục 3–29: đáp ứng/chưa đáp ứng/chưa xác minh; trường hợp * không áp dụng phải ghi căn cứ. Xác nhận của người kiểm tra: .....

Phụ lục tự đánh giá tiểu mục 16 đến 29

Kỳ: ..... Người kiểm tra: .....

Mục	Có tình trạng bất lợi hoặc đáp ứng yêu cầu	Mã minh chứng	Việc cần bổ sung
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			

Mục 1–2: ghi có/không tình trạng bất lợi. Mục 3–29: đáp ứng/chưa đáp ứng/chưa xác minh; trường hợp * không áp dụng phải ghi căn cứ. Xác nhận của người kiểm tra: .....

18 Nguồn đối chiếu và kiểm tra trước trình ký

[1] QĐ6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016, C6.3 trang in 95–96 và phần phương pháp đánh giá.

https://trungtamytehuyentanyen.vn/public/uploads/files/quyet-djinh-6858qdj-byt-nam-2016-ve-bo-tieu-chi-chAt-luong-benh-vien-viet-nam-do-bo-truong-bo-y-te-ban-hanh_5faed01464.pdf

[2] TT31/2021/TT-BYT quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, Điều 4–7.

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152956

[3] Luật Khám bệnh, chữa bệnh 15/2023/QH15, quyền người bệnh và trách nhiệm chuyên môn.

https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-luat-15-2023-qh15-kham-benh-chua-benh-119231127164453959.htm

[4] TT35/2024/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chất lượng cơ bản đối với bệnh viện.

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=171711

Ngày đối chiếu nguồn 16/10/2026. Nguồn chuyên môn từng kỹ thuật do đơn vị phụ trách bổ sung theo danh mục thực tế, không coi QĐ6858 hoặc QĐ3023 là hướng dẫn mọi thao tác lâm sàng.

□ Xác nhận văn bản và hướng dẫn đánh giá kỳ thực tế.

□ Bổ sung thông tin hành chính, nguồn lực và người chịu trách nhiệm.

□ Chuyên khoa rà soát nội dung, chỉ số và tiêu chuẩn nhận diện ca.

□ Phê duyệt biểu mẫu và liên kết hồ sơ bệnh án.

□ Thu thập kết quả thực tế và minh chứng trước khi kết luận mức đạt.